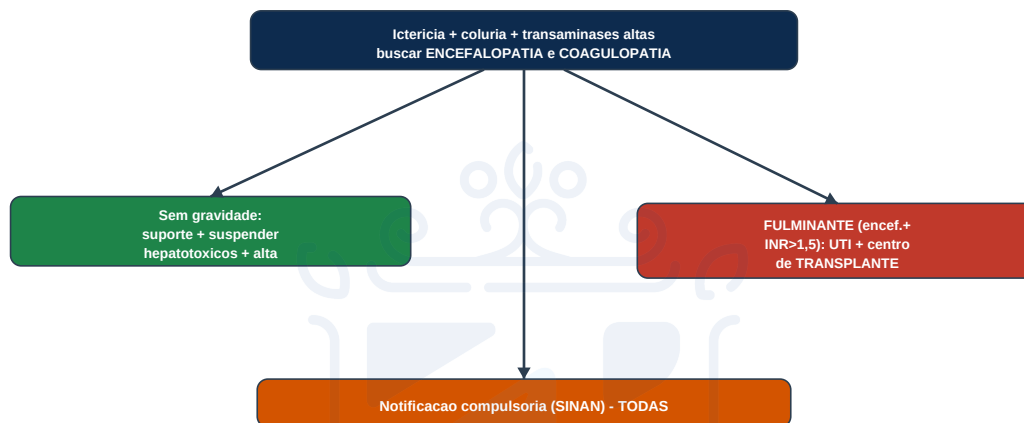


HEPATITES VIRAIS — EXCLUIR FULMINANTE

FLUXOGRAMA — A PRIORIDADE É A FULMINANTE

HEPATITE AGUDA — ICTERÍCIA -> EXCLUIR FALÊNCIA



DEFINIÇÃO, FASES E TRANSMISSÃO

O QUE É

- Inflamação do fígado por vírus hepatotrópicos (A, B, C, D, E) — no PS, foco nas formas AGUDAS (icterícia, colúria, transaminases elevadas)
- Fases: PRÉ-ICTÉRICA (febre baixa, mal-estar, náusea, aversão a cigarro) -> ICTÉRICA (icterícia, colúria, ACOLIA, prurido) -> recuperação (2-6 semanas)
- Transmissão: HAV/HEV = fecal-oral; HBV/HCV/HDV = parenteral/sexual
- Grupos de risco: HAV (crianças, viajantes, saneamento precário); HBV (UDI, sexo desprotegido, profissionais de saúde, hemodialisados); HCV (UDI, transfusão pré-1993, tatuagens); HDV (coinfecção com HBV); HEV (viajantes, GESTANTES — risco fulminante)
- TODAS as hepatites virais são de NOTIFICAÇÃO compulsória (SINAN)

RED FLAGS — HEPATITE FULMINANTE

EMERGÊNCIA

- ENCEFALOPATIA: confusão, ASTERIXIS (flapping), sonolência, coma
- INR > 1,5 (coagulopatia); hipoglicemia (< 60 mg/dL); hipotensão/instabilidade
- Hepatite fulminante = hepatite aguda + encefalopatia em < 8 semanas (mortalidade 50-90% sem transplante)
- Outros sinais de gravidade: vômitos incoercíveis, desidratação, dor abdominal intensa (colangite?), febre alta, oligúria, sangramento espontâneo, icterícia rapidamente progressiva (BT > 20-30)
- Atenção especial: GESTANTES (HEV), hepatopatas crônicos, imunossuprimidos

EXAMES E INTERPRETAÇÃO

Exame	Significado
Triagem	Hemograma, bilirrubinas, TGO/TGP, FA/GGT, TAP/INR, albumina, função renal, glicemia, eletrólitos
Sorologias	HAV: anti-HAV IgM; HBV: HBsAg + anti-HBc IgM; HCV: anti-HCV + HCV-RNA; HDV: anti-HDV (se HBsAg+); HEV: anti-HEV IgM
TGO/TGP > 1000	Viral aguda, tóxica (paracetamol), isquêmica
Padrão	Viral: TGP > TGO (relação < 1); alcoólica: TGO > TGP (relação > 2);olestase: FA/GGT elevados

TRATAMENTO NO PS

Rx SUPORTE + SUSPENDER HEPATOTÓXICOS

Medidas gerais: hidratação VO (ou EV se vômitos — SF 0,9% 1000-1500 mL); dieta leve, hipogordurosa, fracionada; repouso relativo

SUSPENDER: álcool, PARACETAMOL, AINEs e demais hepatotóxicos

Náuseas/vômitos: Metoclopramida 10 mg 8/8h ou Ondansetrona 4-8 mg; prurido: Hidroxizina 25 mg 8/8h ou

Dexclorfeniramina; dor: Dipirona (EVITAR paracetamol)

Antiviral: HBV aguda grave/imunossuprimido -> Tenofovir 300 mg/dia; HCV aguda -> seguimento ambulatorial (maioria autolimitada)

Fulminante: UTI + contatar centro de transplante + antivirais

Imunização pós-exposição: HAV (vacina em até 2 semanas para comunicantes); HBV não vacinado (HBIG 0,06 mL/kg IM + vacina; vacinado -> dosar anti-HBs)

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: hepatite fulminante (encefalopatia, INR > 1,5), vômitos incoercíveis + desidratação, INR > 2/sangramento, BT > 20-25, IRA (Cr > 1,5), alteração de consciência, sepse/colangite, gestante grave, sem seguimento
- ☐ ALTA: sem sinais de gravidade (encefalopatia/coagulopatia/ascite), bilirrubinas estáveis/em queda, INR < 1,5, tolerando VO, consciência normal, orientações compreendidas e retorno garantido
- ☐ Casa: repouso, hidratação 2-3 L/dia, dieta leve, PROIBIDO ÁLCOOL (mín. 6 meses), NÃO usar paracetamol/AINE/suplementos sem orientação
- ☐ Prevenção de transmissão: HAV (higiene de mãos, não preparar alimentos por 2 sem); HBV/HCV (preservativo, não compartilhar lâminas/escovas, não doar sangue); vacinar comunicantes
- ☐ Retorno: hepatologista/infectologista em 7 dias com controle (bilirrubinas, transaminases, INR); alarme: confusão/tremor, vômitos, sangramento, dor intensa/febre, urina muito escura, aumento do abdome, piora da icterícia

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com hepatite viral aguda; icterícia há ____ dias + colúria/acolia; náusea/vômitos ____, dor em HCD ____, prurido ____.
- BT ____ (BD/BI), TGO ____, TGP ____, FA ____, INR ____, albumina ____; sorologias: ____.
- Gravidade: encefalopatia grau ____, flapping ____, INR ____, hipoglicemia ____; sinais vitais ____.
- Solicito internação em ____ (enfermaria/UTI) para suporte / investigação de hepatite fulminante e avaliação de centro de transplante; notificar SINAN.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual achado define a hepatite FULMINANTE, exigindo UTI e contato com centro de transplante?

- A) Icterícia isolada
- B) Hepatite aguda + encefalopatia (e coagulopatia com INR > 1,5) em < 8 semanas
- C) TGP > TGO
- D) Colúria
- E) Febre baixa

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual medicação deve ser SUSPENSA/evitada na hepatite viral aguda?

- A) Dipirona
- B) Paracetamol, AINEs e álcool (hepatotóxicos)
- C) Soro fisiológico
- D) Metoclopramida
- E) Hidroxizina

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual sorologia confirma hepatite A aguda?

- A) Anti-HAV IgG
- B) Anti-HAV IgM
- C) HBsAg
- D) Anti-HCV
- E) Anti-HEV IgG

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Em qual grupo a hepatite E (HEV) tem maior risco de evolução fulminante?

- A) Crianças
- B) Gestantes
- C) Idosos vacinados
- D) Profissionais de saúde
- E) Hemodialisados

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual conduta de imunização pós-exposição é correta para contato não vacinado de hepatite B?

- A) Apenas observação
- B) Imunoglobulina anti-HBV (HBIG 0,06 mL/kg IM) + vacina
- C) Somente antibiótico
- D) Tenofovir profilático isolado
- E) Nenhuma medida

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A hepatite fulminante é a hepatite aguda que evolui com encefalopatia (e coagulopatia, INR > 1,5) em menos de 8 semanas, com alta mortalidade sem transplante.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Suspendem-se os hepatotóxicos: paracetamol, AINEs e álcool. Para dor/febre prefere-se a dipirona.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O anti-HAV IgM confirma hepatite A aguda; o IgG indica infecção passada/imunidade.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A hepatite E (HEV) tem maior risco de forma fulminante em gestantes, especialmente no 3º trimestre.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Contato não vacinado de hepatite B recebe imunoglobulina (HBIG 0,06 mL/kg IM) + vacina; se vacinado, dosa-se o anti-HBs.

SM24
Suporte ao Plantão Médico